STREAM: ¿se pueden suspender las estatinas en mayores de 70 años sin enfermedad cardiovascular?

Rodondi N, Haller ML, Bardoczi JB, Adam L, Blum MR, Gencer B, et al.; STREAM Investigators. Discontinuing statins in older adults without cardiovascular disease. *N Engl J Med*. Publicado en línea el 7 de noviembre de 2026. doi:10.1056/NEJMoa2606634

Versión 1.0 · Revisado el 10 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?

Matiza

Suspender fue "no inferior" según el margen elegido, pero hubo más infartos, ictus y muertes. No respalda suspender por rutina: es una decisión compartida, caso por caso.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?

Sí, con matices

Aleatorizado, con evaluadores y adjudicadores cegados y desenlaces objetivos. Abierto, con 12–14 % de cruce entre grupos y seguimiento de 2 años.

CUIDADO AL INTERPRETAR

No inferior ≠ igual

Todo el intervalo de confianza quedó del lado de "peor al suspender". Lo que lo hizo no inferior fue un margen de 5.2 semanas.

En 30 segundos. En 24 centros de Suiza, Países Bajos y Francia, 1880 personas de **70 años o más** (media 77.5), con **al menos dos enfermedades crónicas**, sin enfermedad cardiovascular conocida y con estatina para prevención primaria desde hacía al menos un año, se asignaron a **suspender** o **continuar** su hipolipemiante. El desenlace fue infarto no fatal, ictus isquémico no fatal o muerte. A 2 años, quienes suspendieron vivieron sin eventos **2.0 semanas menos** en promedio (IC 95 % −3.7 a −0.3), dentro del margen de no inferioridad de −5.2 semanas. Pero en esos 2 años tuvieron un evento **10.7 %** frente a **8.2 %**: según los autores, **un evento más por cada 40** personas que suspenden. Con todo el seguimiento, HR 1.38 (1.05–1.81). Calidad de vida, dolor muscular, caídas y sarcopenia no difirieron, y el comité de seguridad recomendó al final que el grupo que suspendió hablara con su médico sobre reiniciar.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN

Cuando "no inferior" y "peor" son ciertos al mismo tiempo: cómo se elige y se juzga un margen de no inferioridad, qué es el tiempo medio restringido sin eventos, por qué en no inferioridad importan tanto el análisis por protocolo como el de intención de tratar, y cómo traducir el resultado a un número necesario para dañar.

1 La pregunta clínica (PICO)

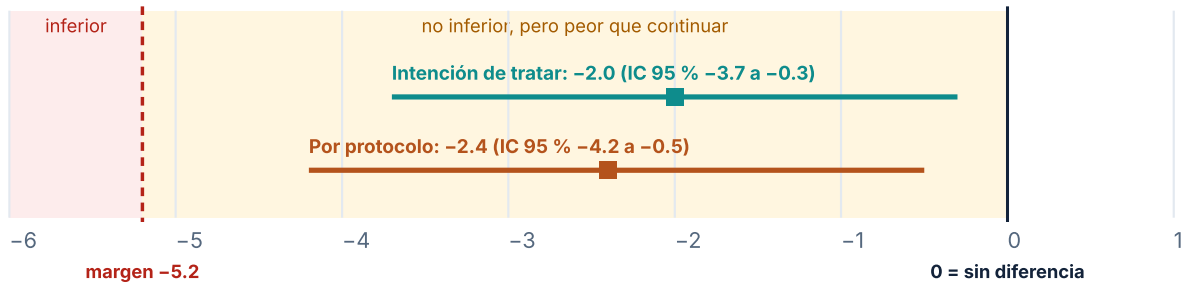
P · POBLACIÓN	Adultos ≥70 años con ≥2 enfermedades crónicas, sin enfermedad cardiovascular aterosclerótica conocida, con estatina para prevención primaria desde hacía ≥1 año. Excluidos: prevención secundaria, enfermedad aórtica que requiere reparación, probable hipercolesterolemia familiar o riesgo elevado de morir en 3 meses. Reclutados en hospitales (46.5 %) y consultorios de medicina general (53.5 %).
I · INTERVENCIÓN	Suspender la estatina y cualquier otro hipolipemiante (sobre todo ezetimiba) en la siguiente toma.
C · COMPARADOR	Continuar la estatina y los demás hipolipemiantes.
O · DESENLACE	Infarto no fatal, ictus isquémico no fatal o muerte por cualquier causa (lo que ocurriera primero), medido como diferencia en el **tiempo medio restringido sin eventos a 2 años**. Margen de no inferioridad: −5.2 semanas.

2 Diseño

TIPO	Ensayo aleatorizado, abierto, de no inferioridad, multicéntrico (24 sitios), con evaluación de desenlaces y adjudicación cegadas. Aleatorización 1:1 estratificada por edad (<75 o ≥75), intensidad de la estatina y tiempo de uso (≤6 o >6 años). Sin placebo.
ANÁLISIS	Modelo de supervivencia paramétrico flexible ajustado por los factores de estratificación. La no inferioridad exigía que el límite inferior del IC 95 % quedara por encima de −5.2 semanas **tanto en intención de tratar como en por protocolo** (este último, con pesos inversos de probabilidad de censura y censurando al cruzarse de grupo). HR con todo el seguimiento como análisis adicional planeado. Secundarios cardiovasculares sin ajuste por multiplicidad.
TAMAÑO	1800 participantes para 89 % de poder en intención de tratar y 83 % por protocolo (alfa unilateral de 0.025). Se aleatorizaron 1880.
SEGUIMIENTO	Mediana de 103 semanas (RIC 52 a 107), por teléfono a los 3 y 12 meses y luego cada año. Retiraron el consentimiento 96 (5.1 %); se perdieron 8.
FINANCIAMIENTO	Fondo Nacional Suizo para la Ciencia (SNSF), entre otros; ensayo iniciado por los investigadores.

3 Resultados

Diferencia en tiempo medio sin eventos a 2 años (suspender − continuar), en semanas



Elaborado por Medicina en Resumen con los datos de la figura 2 del artículo. Los valores negativos favorecen continuar. No reproduce figuras originales.

DESENLACE (PRIMEROS 2 AÑOS)	SUSPENDER (N = 938)	CONTINUAR (N = 942)
Desenlace primario (infarto, ictus o muerte)	**100 (10.7 %)**	**77 (8.2 %)**
Infarto agudo de miocardio	13 (1.4 %)	6 (0.6 %)
Ictus isquémico agudo	18 (1.9 %)	8 (0.8 %)
Muerte por cualquier causa	77 (8.2 %)	65 (6.9 %)
Tiempo medio sin eventos a 2 años	96.5 semanas	98.5 semanas
Primario con todo el seguimiento (mediana 103 semanas)	119 (12.7 %)	87 (9.2 %) · HR 1.38 (1.05–1.81)

OTROS HALLAZGOS	RESULTADO
Colesterol LDL a 12 meses (submuestra de 235)	176.0 mg/dL al suspender frente a 99.4 mg/dL al continuar
Calidad de vida (EQ-5D, 0–100) a 24 meses	88.75 frente a 88.76 (diferencia 0.00; diferencia mínima importante 8)
Dolor muscular (0–100) a 3 meses	3.71 frente a 5.27 (−1.56; IC −3.55 a 0.42; diferencia mínima importante 13)
Al menos una caída a 12 meses	24.7 % frente a 29.0 %; ninguna diferencia significativa tras el ajuste de Benjamini-Hochberg
Cruce al otro grupo	131 (14.0 %) reiniciaron la estatina; 112 (11.9 %) la suspendieron
Al menos un evento adverso grave	43.0 % frente a 39.8 %
Subgrupo por sitio de reclutamiento	Medicina general: −3.4 semanas; hospital: −1.1 semanas

4 Cómo leer estos resultados

- **No inferior y peor, al mismo tiempo.** DATO DEL ARTÍCULO La diferencia fue −2.0 semanas, con IC 95 % de −3.7 a −0.3: el límite inferior quedó por encima del margen (−5.2) y por eso se declaró no inferior. INTERPRETACIÓN Pero el límite superior (−0.3) tampoco llega a cero: todo el intervalo está del lado de "suspender es peor". Un ensayo de no inferioridad no pregunta "¿son iguales?", sino "¿la pérdida es menor que lo que estamos dispuestos a aceptar?". Aquí la respuesta es "sí, se pierde algo, y es menos de 5.2 semanas en 2 años".
- **El margen es una decisión, no un dato.** DATO DEL ARTÍCULO Se fijó en −5.2 semanas, equivalente a perder 5 % del tiempo sin eventos en 2 años, y se publicó antes en el protocolo. INTERPRETACIÓN Que se haya fijado antes es correcto; que sea aceptable lo decide el lector. Para alguien que quiere dejar una pastilla por efectos adversos o carga de medicamentos, quizá sí; para alguien con riesgo alto y buena tolerancia, probablemente no. En la mayoría de las personas el margen se juzga mejor en números absolutos que en semanas.
- **Pásalo a números absolutos.** DATO DEL ARTÍCULO En 2 años, 10.7 % frente a 8.2 %: los autores lo traducen a un infarto, ictus o muerte más por cada 40 personas que suspenden. Infarto (1.4 vs. 0.6 %) e ictus (1.9 vs. 0.8 %) se duplicaron, con pocos eventos. INTERPRETACIÓN Un NND de 40 en 2 años es un efecto clínicamente relevante. Los componentes son secundarios, con pocos eventos y sin ajuste por multiplicidad; los autores advierten que sus IC no deben usarse para inferir efectos. Aun así, todos van en la misma dirección.
- **Tiempo medio restringido sin eventos.** DATO DEL ARTÍCULO Es el área bajo la curva de supervivencia sin eventos hasta los 2 años: 96.5 semanas al suspender y 98.5 al continuar. INTERPRETACIÓN No depende de que los riesgos sean proporcionales y se entiende en tiempo, pero "2 semanas en promedio" suena pequeño porque reparte el daño entre todos: en realidad, la mayoría no tuvo eventos en ninguno de los dos grupos, y unos pocos los tuvieron mucho antes. Por eso conviene leerlo junto con el porcentaje de eventos y el HR (1.38 con todo el seguimiento).
- **En no inferioridad, la intención de tratar no basta.** DATO DEL ARTÍCULO El 14.0 % del grupo que suspendió reinició la estatina (44 por lípidos altos) y el 11.9 % del grupo que continuaba la suspendió. Se exigió no inferioridad también por protocolo (−2.4; −4.2 a −0.5), y un análisis de punto de inflexión indicó que los cruces difícilmente cambiarían la conclusión. INTERPRETACIÓN En superioridad, los cruces hacen que los grupos se parezcan y diluyen la diferencia, lo que vuelve conservador al análisis por intención de tratar. En no inferioridad pasa lo contrario: diluir la diferencia *favorece* declarar no inferioridad. Por eso pedir ambos análisis fue lo correcto, y en los dos el daño apareció.
- **Lo que buscaban ganar no apareció.** DATO DEL ARTÍCULO Sin diferencias en calidad de vida, dolor muscular, caídas, sarcopenia ni apego. INTERPRETACIÓN La razón habitual para desprescribir es mejorar la calidad de vida. En esta población, que no se había quejado necesariamente de la estatina, no hubo ganancia que compensara el exceso de eventos. Los autores señalan que quienes querían dejarla por dolor muscular quizá no aceptaron entrar al ensayo.

CONCEPTO CLAVE · CÓMO LEER UN ENSAYO DE NO INFERIORIDAD

Coloca el IC 95 % de la diferencia sobre una recta con dos referencias: el **cero** y el **margen**. **Si el IC cruza el margen:** no se demuestra no inferioridad. **Si queda entre el margen y el cero sin tocar el cero (como aquí):** no inferior, pero peor. **Si cruza el cero sin llegar al margen:** no inferior y sin diferencia demostrada. **Si queda del lado favorable sin tocar el cero:** además, superior. Pregúntate siempre si el margen es clínicamente aceptable para tu paciente y revisa que la conclusión se sostenga también por protocolo.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
● Aleatorización y cegamiento del desenlace	Aleatorización web estratificada; evaluadores telefónicos y comité de adjudicación sin conocer el grupo; desenlaces objetivos.	Confirmado
● Margen preespecificado	Publicado en el protocolo; no inferioridad exigida en intención de tratar y por protocolo.	Confirmado
● Diseño abierto, sin placebo	No era factible un placebo para tantas estatinas y dosis; el grupo asignado se revelaba al final de cada llamada para evaluar el apego.	Reconocido por los autores
● Cruces entre grupos	14.0 % y 11.9 %; se mitigaron con análisis por protocolo ponderados y de punto de inflexión.	Reconocido por los autores
● Otros fármacos cardiovasculares	No se pudieron excluir cambios en otros tratamientos preventivos durante el seguimiento; la diferencia entre grupos fue <10 puntos.	Reconocido por los autores
● Seguimiento corto	Mediana de 2 años; el exceso de eventos apareció meses después de suspender, sin protección aparente por los años previos de estatina.	Interpretación editorial
● Aplicabilidad	Europa occidental, ≥70 años con multimorbilidad y mortalidad alta (15.1 % a 3 años). No aplica a prevención secundaria ni a quien tiene efectos adversos claros por la estatina; el riesgo cardiovascular no se pudo calcular en 353 participantes por falta de lípidos.	Interpretación editorial

Pregunta de repaso: una mujer de 79 años, con diabetes tipo 2, osteoartritis y ERC 3a, toma atorvastatina para prevención primaria desde hace 8 años, sin molestias. Su hija pregunta si ya puede dejarla "porque salió un estudio que dice que es igual". ¿Qué le respondes?
Respuesta. Que el estudio no dice que sea igual. Suspender fue no inferior según un margen que los propios investigadores eligieron, pero quienes la dejaron tuvieron más infartos, ictus y muertes: alrededor de un evento más por cada 40 personas en 2 años, sin mejorar la calidad de vida, el dolor ni las caídas. Si tolera bien la estatina y su expectativa de vida no es corta, la evidencia favorece continuarla. Suspender sigue siendo razonable como decisión compartida cuando hay efectos adversos, fragilidad avanzada, expectativa de vida limitada o una carga de medicamentos que la paciente prioriza reducir.

¿Qué aprendí de medicina?

- En ≥70 años con multimorbilidad y sin ECV, suspender la estatina aumentó infarto, ictus o muerte (10.7 vs. 8.2 % a 2 años).
- No mejoró calidad de vida, dolor, caídas ni sarcopenia.
- Desprescribir la estatina es una decisión individual, no una regla por edad.

¿Qué aprendí de investigación?

- No inferior no es igual: mira el IC contra el cero y contra el margen.
- En no inferioridad, los cruces favorecen la conclusión: exige también el análisis por protocolo.
- Traduce el resultado a números absolutos (NND).

6 Referencias

1. Rodondi N, Haller ML, Bardoczi JB, Adam L, Blum MR, Gencer B, et al. Discontinuing statins in older adults without cardiovascular disease. N Engl J Med. 2026. doi:10.1056/NEJMoa2606634

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.